38A8A65E380043F6F85B715B74B7D8D89889BE8D41A84BF9E952B47EC91FD0B0

# 健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT

38A8A65E380043F6F85B715B74B7D8D89889BE8D41A84BF9E952B47EC91FD0B0

项目号：T011840011　　女 性别：

单　　位：

联系电话：　　项目简称：朴新教育

员 工 号：　　类　　别：员工

卡　　号：0010900115979670　　部　　门：

递送地址：

报告递送方式：不要纸质报告

体 检 号：21201805123

爱康国宾北京中关村国宾体检分院（北京爱康国宾中关门诊部）

检查日期：2018.05.12

29 / 1014

爱康国宾

爱康国宾是中国最大的健康管理集团之一，每年为数百万客户提供健康体检、疾病检测、齿科服务和私人医生等服务。依托旗下健康医疗服务中心、IT技术平台和强大的客户服务体系，爱康国宾为个人及团体提供从体检、检测、医疗、齿科、家庭医生、慢病管理、健康保险等全方位个性化服务，帮助其全面摆脱亚健康、预防慢性病、解决就医难，为根本提高现代中国人的整体健康水平和生命质量作贡献。同时，爱康国宾为保险公司以及银行提供第三方的健康管理服务以及客户关系管理的解决方案

爱康的体检中心城市（已在官网正式上线展示的城市）包括：北京，上海，广州，深圳，南京，成都，凯里，杭州，苏州，重庆，天津，长春，沈阳，绵阳，烟台，济南，潍坊，威海，青岛，常州，镇江，江阴，无锡，芜湖，宁波，福州，佛山，长沙，武汉，西安，银川，贵阳，毕节。

爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有　　www.ikang.com

尊敬的 李美女 女士：您好！

爱康国宾北京中关村国宾体检分院（北京爱康国宾中关门诊部）感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您2018年05月12日的体检报告呈上。

## 报告阅读说明

您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。

健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果，并非能覆盖人体全部器官及全部指标。

您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果，隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整，可能会导致相关检查结论有偏差。

因为检查方法的不同，针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。

由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性，本次体检未见异常并不代表没有疾病，如您有不适症状，请及时到医院就诊。

38A8A65E380043F6F85B715B74B7D8D89889BE8D41A84BF9E952B47EC91FD0B0

# 阳性结果和异常情况

【1】 体重指数增高

【2】 血压增高

【3】 屈光不正

【4】 乳腺增生

【5】 血常规检查红细胞压积增高；血红蛋白轻度增高

【6】 血白细胞增多；中性粒细胞绝对值增高

【7】 宫颈TCT提示轻度炎症反应性细胞改变

【8】 尿素氮降低

【9】 糖类抗原724增高

38A8A65E380043F6F85B715B74B7D8D89889BE8D41A84BF9E952B47EC91FD0B0

# 专家建议与指导

【1】体重指数增高：
1、体重指数（体重(kg)÷身高(m)的平方）≥24为超重，≥28为肥胖。
2、饮食宜低脂肪、低糖、低盐，控制主食量，辅以适量优质蛋白（鱼、蛋、奶类等）以及各种蔬菜。
3、加强运动消耗多余脂肪。可依年龄及身体状况，选择适合自己的运动方式和运动时间，以达到减轻体重的目的。
4、推荐运动三要素，频率：每周至少三次；强度：心率达到（170－年龄）次/分；时间：平均每次半小时以上。运动以微汗为宜。

【2】血压增高：
1、收缩压≥140mmHg和/或舒张压≥90mmHg。
2、请监测血压，若三次以上非同日测得收缩压≥140mmHg和/或舒张压≥90mmHg，建议去医院专科确诊。
3、高血压与遗传、肥胖、饮食习惯、睡眠、精神压力等因素有关。建议您改善生活方式，戒烟限酒，低脂、低盐、合理膳食，坚持有氧运动，控制体重，减轻精神压力、保持心理平衡等。

【3】屈光不正：
1、屈光不正包括近视、远视、散光。
2、注意用眼卫生。
3、用眼时间稍长可适当闭目休息或做眼保健操和远眺。
4、请定期检查视力，建议到正规医疗机构验光，配戴合适的眼镜。

【4】乳腺增生：
1、也称为乳腺囊性增生病,是女性常见病之一，其发生与全身内分泌失调和精神因素密切相关，因此建议您少食高热量、高脂肪食品，避免食用或使用含雌激素的保健品和化妆品，保持乐观情绪，加强有氧运动，维持理想体重。
2、每月进行1次乳房自我检查，方法为：平卧位，手指并拢，按顺序轻压乳房，观察有无疼痛、肿块，检查腋下有无淋巴结肿大，最后轻压乳头注意有无异常分泌物。
3、建议定期复查。

【5】血常规检查红细胞压积增高；血红蛋白轻度增高：
上述改变，目前无重要意义，可动态观察。

【6】血白细胞增多；中性粒细胞绝对值增高：
1、可见于部分生理情况下，如剧烈运动、劳动后、饱餐、高温、女性妊娠后期等。
2、病理情况多见于急性感染、严重损伤、血细胞破坏、急性大出血、中毒、血液病等。
3、建议结合临床参考，一周后复查。
4、如有发热请到医院就诊进一步明确诊断。

【7】宫颈TCT提示轻度炎症反应性细胞改变：
当宫颈炎症时，可出现良性反应性细胞改变，多数情况下属正常现象，无需特殊治疗，建议一年后复查。

【8】尿素氮降低：
可见于严重肝脏疾病，如无相关病史，无重要意义，必要时复查。

【9】糖类抗原724增高：
1、糖类抗原724常用于胃肠道及卵巢肿瘤的辅助诊断，在卵巢癌及胃癌患者明显升高；大肠癌、子宫癌、胰腺癌等患者也升高；但有时也可见于少数正常人及良性胃肠道疾病患者。
2、糖类抗原724增高是否具有临床意义，需专科结合临床综合分析，以明确诊断，排除怀疑。
3、建议到医院消化科或肿瘤科就诊咨询，明确诊断。不明原因的轻度增高需定期复查随访。

# 进一步检查项目建议

（基于发现的异常结果，建议您做以下检查，从而进一步排除或确定您的健康隐患）

| 序号 | 发现的异常结果 | 建议进一步检查的项目<br>（最终以临床医师意见为准） |
|---|---|---|
| 1 | 血压增高 | 必要时，应进行24小时动态血压监测或家庭血压监测。 |

主要参考：国家卫生和计划生育委员会、中华医学会、美国癌症学会、美国心脏学会、美国妇产科医师学会等学术机构发布的相关标准

# 异常结果复查建议



38A8A65E380043F6F85B715B74B7D8D89889BE8D41A84BF9E952B47EC91FD0B0
38A8A65E380043F6F85B715B74B7D8D89889BE8D41A84BF9E952B47EC91FD0B0

| 序号 | 发现的异常结果 | 复查建议<br>（最终以临床医师意见为准） |
|---|---|---|
| 1 | 体重指数增高 | 3-12个月复查。 |
| 2 | 舒张压增高 | 半个月-1个月复查。 |
| 3 | 乳腺增生 | 每年复查一次。 |

38A8A65E380043F6F85B715B74B7D8D89889BE8D41A84BF9E952B47EC91FD0B0

# 健康体检结果

## · 一般项目检查

检查者：陈颖

| 检查项目 | 测量结果 | 单位 | 异常描述 | 正常参考值 |
|---|---|---|---|---|
| 身高 | 171 | cm | | |
| 体重 | 70.3 | Kg | | |
| 体重指数 | 24.0 | | ↑ | 18.5 -- 23.99 |
| 收缩压 | 115 | mmHg | | 90 -- 139 |
| 舒张压 | 93 | mmHg | ↑ | 60 -- 89 |
| 初步意见 | 体重指数增高<br>舒张压增高<br>血压增高 | | | |

## · 内科

检查者：杜丽亚

| 检查项目 | 检查所见 | 单位 |
|---|---|---|
| 病史 | 无 | |
| 家族史 | 无特殊 | |
| 心率（次/分） | 68 | 次/分 |
| 心律 | 齐 | |
| 心音 | 正常 | |
| 肺部听诊 | 双侧呼吸音未闻及异常 | |
| 肝脏触诊 | 肝脏肋下未触及 | |
| 脾脏触诊 | 脾脏肋下未触及 | |
| 肾脏叩诊 | 双肾区无叩痛 | |
| 内科其它 | 无 | |
| 初步意见 | 未见明显异常 | |

38A8A65E380043F6F85B715B74B7D8D89889BE8D41A84BF9E952B47EC91FD0B0

## · 外科

检查者：葛淑恩

| 检查项目 | 检查所见 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 皮肤 | 未见明显异常 | |
| 浅表淋巴结 | 颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常 | |
| 甲状腺(外科) | 未见明显异常 | |
| 乳房 | 双侧乳腺弥漫性增厚，增厚区与周围乳腺组织分界不明显，颗粒不伴触痛 | |
| 脊柱 | 未见明显异常 | |
| 四肢关节 | 未见明显异常 | |
| 肛门、直肠指诊 | 放弃检查 | |
| 外科其它 | 无 | |
| 初步意见 | 乳腺增生 | |

## · 妇科

检查者：陈御芳

| 检查项目 | 检查所见 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 外阴 | 未见明显异常 | |
| 阴道 | 未见明显异常 | |
| 宫颈 | 未见明显异常 | |
| 子宫 | 未见明显异常 | |
| 附件 | 未扪及明显异常 | |
| 妇科其它 | 无 | |
| 初步意见 | 未见明显异常 | |

## · 眼科

检查者：付伟仁

| 检查项目 | 检查所见 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 裸视力(右) | 1.2 | |
| 裸视力(左) | 0.6 | |
| 矫正视力(右) | | |
| 矫正视力(左) | | |
| 色觉 | 正常 | |
| 外眼 | 未见明显异常 | |
| 眼科其它 | 无 | |
| 眼底镜检查 | 未见明显异常 | |
| 裂隙灯检查 | 未见明显异常 | |

38A8A65E380043F6F85B715B74B7D8D89889BE8D41A84BF9E952B47EC91FD0B0
38A8A65E380043F6F85B715B74B7D8D89889BE8D41A84BF9E952B47EC91FD0B0

| 初步意见 | 屈光不正 |
|---|---|

## · 血常规

操作者：岳钟华　审核者：吴荣芝

| 检查项目 | 缩写 | 测量结果 | 提示 | 参考区间 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白细胞计数 | WBC | 10.0 | ↑ | 3.5 -- 9.5 | 10^9/L |
| 红细胞计数 | RBC | 5.08 | | 3.8 -- 5.1 | 10^12/L |
| 血红蛋白 | Hb | 154 | ↑ | 115 -- 150 | g/L |
| 红细胞压积 | HCT | 0.472 | ↑ | 0.35 -- 0.45 | L/L |
| 平均红细胞体积 | MCV | 92.9 | | 82.0 -- 100.0 | fL |
| 平均红细胞血红蛋白含量 | MCH | 30.3 | | 27.0 -- 34.0 | pg |
| 平均红细胞血红蛋白浓度 | MCHC | 326 | | 316 -- 354 | g/L |
| 红细胞分布宽度-变异系数 | RDW-CV | 13.3 | | 10 -- 15 | % |
| 血小板计数 | PLT | 300 | | 125 -- 350 | 10^9/L |
| 平均血小板体积 | MPV | 9.9 | | 6.8 -- 13.5 | fL |
| 血小板分布宽度 | PDW | 10.7 | | 10 -- 18 | % |
| 淋巴细胞百分比 | LYMPH% | 30.4 | | 20.0 -- 50.0 | % |
| 中间细胞百分比 | MON% | 5.4 | | 3 -- 12 | % |
| 中性粒细胞百分比 | NEUT% | 64.2 | | 40 -- 75 | % |
| 淋巴细胞绝对值 | LYMPH | 3.00 | | 1.1 -- 3.2 | 10^9/L |
| 中间细胞绝对值 | MON# | 0.60 | | 0.1 -- 0.8 | 10^9/L |
| 中性粒细胞绝对值 | NEUT | 6.40 | ↑ | 1.8 -- 6.3 | 10^9/L |
| 小结 | 红细胞压积增高<br>中性粒细胞绝对值增高<br>血红蛋白轻度增高<br>血白细胞增多 | | | | |

此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

## · 尿常规

操作者：崔淑慧　审核者：岳钟华

| 检查项目 | 缩写 | 测量结果 | 提示 | 参考区间 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尿比重 | SG | 1.020 | | 1.005 -- 1.030 | |
| 尿酸碱度 | PH | 6.0 | | 4.5 -- 8.0 | |
| 尿白细胞 | LEU | 阴性 | | 阴性 | |
| 尿亚硝酸盐 | NIT | 阴性 | | 阴性 | |
| 尿蛋白质 | PRO | 阴性 | | 阴性 | |



38A8A65E380043F6F85B715B74B7D8D89889BE8D41A84BF9E952B47EC91FD0B0
38A8A65E380043F6F85B715B74B7D8D89889BE8D41A84BF9E952B47EC91FD0B0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 尿糖 | GLU | 阴性 | | 阴性 | |
| 尿酮体 | KET | 阴性 | | 阴性 | |
| 尿胆原 | URO | 阴性 | | 阴性 | |
| 尿胆红素 | BIL | 阴性 | | 阴性 | |
| 尿隐血 | BLD | 阴性 | | 阴性 | |
| 小结 | 未见明显异常 | | | | |

此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

## · 实验室检查

操作者：迪安、康双艳、赵丹丹　审核者：张萍、曹文玲、陈卉

| 检查项目 | 缩写 | 测量结果 | 提示 | 参考区间 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丙氨酸氨基转移酶 | ALT | 9 | | 0 -- 50 | U/L |
| 天门冬氨酸氨基转移酶 | AST | 13 | | 0 -- 40 | U/L |
| γ-谷氨酰转移酶 | GGT | 19 | | 8 -- 45 | U/L |
| 尿素 | UREA | 2.54 | ↓ | 2.78 -- 7.85 | mmol/L |
| 肌酐 | Cr | 74 | | 35 -- 106 | umol/L |
| 尿酸 | UA | 273 | | 150 -- 420 | umol/L |
| 空腹血葡萄糖 | FBG | 5.69 | | 3.61 -- 6.11 | mmol/L |
| 总胆固醇 | TC | 5.49 | | 3.10 -- 5.72 | mmol/L |
| 甘油三酯 | TG | 1.63 | | 0.51 -- 1.70 | mmol/L |
| 高密度脂蛋白胆固醇 | HDL-C | 1.36 | | 0.83 -- 1.96 | mmol/L |
| 低密度脂蛋白胆固醇 | LDL-C | 3.04 | | 0 -- 3.12 | mmol/L |
| 甲胎蛋白定量 | AFP | 1.10 | | 0 -- 20 | ng/ml |
| 癌胚抗原定量 | CEA | 0.78 | | 0 -- 5 | ng/ml |
| 糖类抗原724 | CA-724 | 10.05 | ↑ | 0.000 -- 6.900 | KU/L |
| 小结 | 尿素降低<br>糖类抗原724增高 | | | | |

此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

## · 妇科检验项目

操作者：陈莎　闫占力　马红磊

| 检查项目 | 缩写 | 测量结果 | 提示 | 参考区间 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宫颈TCT | | 轻度炎症反应性细胞改变 | | | |
| ★<br>人乳头瘤病毒分型（HPV分型） | HPV分型 | 阴性 | | 阴性 | |
| 小结 | 宫颈TCT：轻度炎症反应性细胞改变 | | | | |



38A8A65E380043F6F85B715B74B7D8D89889BE8D41A84BF9E952B47EC91FD0B0
38A8A65E380043F6F85B715B74B7D8D89889BE8D41A84BF9E952B47EC91FD0B0

38A8A65E380043F6F85B715B74B7D8D89889BE8D41A84BF9E952B47EC91FD0B0

## · 心电图室

检查者：张兵

| 检查项目 | 检查所见 | 单位 |
|---|---|---|
| 心电图 | 窦性心律 正常心电图 | |
| 初步意见 | 未见明显异常 | |

## · 超声检查室

检查者：张云飞

| 检查项目 | 检查所见 | 单位 |
|---|---|---|
| 甲状腺 | 未见明显异常 | |
| 乳腺 | 双侧乳腺组织稍增厚，内部回声欠均匀 | |
| 肝 | 未见明显异常 | |
| 胆 | 未见明显异常 | |
| 胰 | 未见明显异常 | |
| 脾 | 未见明显异常 | |
| 双肾 | 未见明显异常 | |
| 子宫 | 子宫形态大小正常，肌层回声均匀，内膜线显示清晰，厚度正常范围，宫颈厚度正常 | |
| 附件 | 双侧卵巢显示清晰，形态大小正常，CDFI:血流显示正常 | |
| 初步意见 | 乳腺增生(双侧) | |

## · 放射科

检查者：庞巧云

| 检查项目 | 检查所见 | 单位 |
|---|---|---|
| 胸部 | 双肺纹理较清晰，肺野未见明显实变影。双肺门结构尚清晰。心影大小尚属正常范围之内。双侧膈面光整，肋膈角锐利。 | |
| 初步意见 | 未见明显异常 | |

评审医师：玉泉　　主检医师：

# 医学名词科普知识

医学名词科普知识内容，仅是帮助您解读理解体检报告使用，所有名词的解释内容，均出自国家权威性专业典籍，部分内容略有增减，仅供您阅读参考。

38A8A65E380043F6F85B715B74B7D8D89889BE8D41A84BF9E952B47EC91FD0B0

## 什么是体重指数？

目前常用的体重指数（body mass lndex）简称BMI，又译为体质指数。在判断肥胖程度时，使用这个指标的目的在于消除不同身高对体重指数的影响，以便于人群或个体间比较。研究表明，大多数个体的体重指数与身体脂肪的百分含量有明显的相关性，能较好地反映机体的肥胖程度。但在具体应用时还应考虑到其局限性，如对肌肉很发达的运动员或有水肿的病人，体重指数值可能过高估计其肥胖程度。老年人的肌肉组织与其脂肪组织相比，肌肉组织的减少较多，计算的体重指数值可能过低估计其肥胖程度。相等BMI值的女性的体脂百分含量一般大于男性。同时测定体脂百分含量（体脂%）会有助于判断肥胖程度。

## 什么是血压？

人体血液不停流动的原动力是我们的心脏，心脏收缩时血液送入主动脉，心脏舒张时血液从体循环回流至心脏。心脏的收缩和舒张交替进行，推动血液在心脏和血管组成的密闭循环系统内持续流动。血液在血管内流动时对血管壁造成的压力，叫做血压。当心脏收缩时，大量的血液射入动脉，此时血液对动脉的压力最高，称为收缩压（俗称高压）。健康的动脉壁富有弹性，当心脏收缩时射入动脉的血液有一部分会暂时蓄积在弹性膨胀的主动脉内，而不是一次性地送入全身，这样就保证了收缩压不会升得太高。心脏舒张时，受到高压力而膨胀的大动脉弹性回缩，使血液仍能持续向前流动，但压力下降，此时的血压称为舒张压（俗称低压）。

## 什么是屈光不正？

在调节松弛的状态下，正视状态的眼球（正常屈光），入射光线经过角膜、晶状体后聚焦于视网膜表面，形成清晰的图像传入大脑。晶状体具有弹性，年轻人的弹性更好。调节时，睫状肌调整晶状体形状以更好的聚焦影像。屈光不正是指眼在调节松弛的状态下，平行光线经过眼的屈光系统屈折后，不能把光线聚焦成清晰的图像在视网膜上，而成像于视网膜前或后，造成眼视物模糊。屈光不正包括远视、近视和散光。屈光不正的主要症状为视远和（或）视近时视物模糊。有时候，睫状肌张力过高可能引起头痛症状。偶尔，长时间注视可能导致眼表面干燥，引起眼部刺激症状、眼痒、视觉疲劳、异物感和眼红。儿童表现为阅读时皱眉和过度眨眼或者揉眼。矫治近视眼需配戴合适度数的凹透镜，使平行光线在进入眼以前发散，经眼屈光系统后聚焦于视网膜上。同理，矫治远视眼需配戴合适度数的凸透镜，矫治散光需配戴柱镜或球柱镜。散光眼即使度数很轻，若有视力下降，或出现视疲劳症状者，都应当配戴矫正眼镜。对于高度散光眼或不规则散光眼，当镜片无法矫治时可以考虑配戴硬性接触镜或行准分子激光手术治疗。

38A8A65E380043F6F85B715B74B7D8D89889BE8D41A84BF9E952B47EC91FD0B0

## 什么是淋巴结肿大？

淋巴结肿大是一种病理状态，常指示有局部或全身疾病存在。人体淋巴结遍布机体内多处，分浅、深2大部分，各部分又分数组。浅部淋巴结分布于耳后、枕后、颌下、颈前后、锁骨上、腋窝、腘窝、腹股沟等处；深部淋巴结分布在肺门、肠系膜及其他内脏附近及大血管旁。淋巴结肿大情况复杂，如大小不一、质地不同、形态各异、发展有别。多种原因可引起，如各种微生物感染、结核感染、血液系统疾病、淋巴系统本身疾病、结缔组织疾病、恶性肿瘤转移等。对于无明显原因的淋巴结肿大应认真检查，必要时进行病理学检查，对于诊断某些疾病意义重大。

## 什么是乳腺增生？

乳腺增生又名乳腺结构不良，可分为囊性小叶增生、腺性小叶增生和纤维性小叶增生。乳腺增生是生理过程中，或在某些激素分泌失调情况下，表现出乳腺组织成分的大小和数量构呈比例及形态上的周期性变化，是一组临床综合征。乳腺增生并非炎症性或肿瘤性疾病，甚至其大多数情况下都是代表乳腺组织对激素的生理性反应，而不是真正的疾病。仅有少部分可能属于疾病，其中极少数出现非典型增生，可再发展成原位癌，甚至最终演变成为浸润性乳腺癌。注意，这个过程并非线性进展，随时可以在浸润性乳腺癌之前的任一环节停下来，所以不能把乳腺增生视作癌前期病变。乳腺增生可发生于青春期至绝经期的任何年龄，以20～40岁多见，35～40岁为高峰。常为双侧，亦可单侧发病，病变呈多发、弥漫性分布。多无明显症状；少数可有疼痛感或胀痛，疼痛与月经周期有关，经前明显，经后减轻；部分患者疼痛与情绪有关。发病初期可无明显体征，到一定阶段表现出乳腺组织增厚感或结节感，可有压痛。腋下淋巴结不肿大。

## 什么是血红蛋白？

血红蛋白是红细胞内负责运载氧的一种蛋白质，血液呈红色就是因为含有血红蛋白。它能从肺携

带氧，经由动脉血运送给组织，又能携带组织代谢所产生的二氧化碳，经静脉血送到肺再排出体外。生理情况下，红细胞的生成与衰亡保持动态平衡。多种原因可使这种平衡遭到破坏，导致红细胞和血红蛋白数量减少或增多。

### 什么是尿素氮？

血尿素氮是蛋白质代谢的终末产物，因此血液中尿素氮的生成量受饮食中蛋白质摄入量、组织蛋白质分解代谢情况以及肝功能状况等的影响。当肾脏受到损害时，使血尿素氮浓度增加，因此测定尿素氮可以作为判断肾脏损害情况的指标之一。

38A8A65E380043F6F85B715B74B7D8D89889BE8D41A84BF9E952B47EC91FD0B0

38A8A65E380043F6F85B715B74B7D8D89889BE8D41A84BF9E952B47EC91FD0B0

## 深度咨询或风险评估产品建议

尊敬的客户，根据您的检测结果评估，您有一定程度的胃肠疾病风险，建议您选择“常卫清”肠胃专项深度筛查产品。如需了解更多，您可以关注我们的产品宣传单，或下载爱康APP，了解更多和购买。

iKang 爱康

扫码下载爱康APP

想第一时间看到体检报告？
想对比您的历史体检报告？

爱康APP，检前检后全管理！

约体检 查报告 历史数据对比 专家解读 三甲医院挂号

iKangCare+，有人“管”的体检！